TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Bloqueios nervosos

Identificação

Paciente (nome civil):

Nome social, se houver:

Data de nascimento: CPF:

RG: Estado civil e profissão:

Endereço:

Celular: E-mail:

Procedimento: Bloqueio nervoso

Área(s) a ser(em) tratada(s):

Local do procedimento:

Data prevista:

Médica responsável: Dra. Dunia Verona · Cirurgiã plástica · CRM-RJ 52 0126416-8 · RQE 60527 · Membro da SBCP

Responsável legal (se paciente menor de idade ou incapaz):

_____

Por meio deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, eu, paciente identificado(a) acima, declaro que, em consulta realizada em ____/____/_____ com a Dra. Dunia Verona, cirurgiã plástica (CRM-RJ 52 0126416-8 · RQE 60527), recebi informações verbais e por escrito sobre o procedimento de BLOQUEIO NERVOSO, ao qual me submeterei voluntariamente. As informações foram dadas em linguagem clara e acessível, tive tempo para refletir e todas as minhas dúvidas foram respondidas, em conformidade com os artigos 22, 24, 31 e 34 do Código de Ética Médica (Resolução CFM nº 2.217/2018), com a Recomendação CFM nº 1/2016 e com o artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor. Declaro estar ciente dos benefícios esperados, das alternativas, dos riscos e das possíveis complicações, conforme descrito a seguir.

1. Da natureza do procedimento e da obrigação assumida

Todo procedimento médico tem, ao mesmo tempo, efeitos sobre a forma e sobre a saúde, entendida como o conjunto de bem-estar físico, mental e social.

A Dra. Dunia Verona se compromete a indicar o procedimento apenas quando adequado ao meu caso e a empregar a técnica adequada, com diligência, prudência e de acordo com o conhecimento científico atual. Fui informado(a) de que o resultado depende também de fatores biológicos individuais, que fogem ao controle da médica (como cicatrização, qualidade da pele, resposta do organismo ao produto ou à cirurgia), e da minha adesão às orientações antes e depois do procedimento.

Não me foi prometido nem garantido um resultado específico. Fotografias de outros pacientes, simulações ou imagens de referência eventualmente mostradas na consulta têm caráter apenas ilustrativo e não representam promessa de resultado.

2. Do procedimento de bloqueios nervosos e seus benefícios

- Os bloqueios nervosos são procedimentos intervencionistas frequentemente utilizados para aliviar a dor crônica ou aguda.
- O benefício primário dos bloqueios nervosos é o alívio da dor. Ao interromper temporariamente a transmissão de sinais de dor ao longo dos nervos, esses procedimentos podem proporcionar alívio imediato.
- Em alguns casos, os bloqueios nervosos são usados como ferramenta diagnóstica. Ao bloquear seletivamente um nervo específico e observar a resposta do paciente, os médicos podem determinar a fonte exata da dor.
- A administração de corticosteroides durante os bloqueios nervosos pode ajudar a reduzir a inflamação ao redor dos nervos, proporcionando alívio prolongado.
- Ao controlar a dor de maneira eficaz, os bloqueios nervosos podem melhorar significativamente a qualidade de vida do paciente. Isso pode permitir a retomada de atividades diárias normais e a participação em outras terapias de reabilitação.
- Em alguns casos, os bloqueios nervosos podem ser uma alternativa menos invasiva e arriscada à cirurgia. Eles podem ser considerados como uma opção antes de procedimentos mais agressivos.
- Os bloqueios nervosos podem ser parte de um plano de tratamento multidisciplinar, complementando outras abordagens, como fisioterapia, medicamentos e terapias cognitivo-comportamentais.
- Reduzir a dor através de bloqueios nervosos pode permitir a redução do uso de analgésicos orais, minimizando assim os efeitos colaterais associados a esses medicamentos.

- Muitos bloqueios nervosos são procedimentos ambulatoriais que permitem uma recuperação rápida. Os pacientes geralmente podem retomar suas atividades normais logo após o procedimento.
- Ao reduzir a dor e a inflamação, os bloqueios nervosos podem ajudar a melhorar a função física do paciente, permitindo maior mobilidade e flexibilidade.
- Em situações em que a dor intensa é um obstáculo para a reabilitação, os bloqueios nervosos podem proporcionar um período de alívio suficiente para permitir que o paciente participe ativamente de programas de reabilitação física.
- Existem algumas diferentes técnicas para realizar bloqueios nervosos, e a escolha depende da localização do nervo alvo. As técnicas comuns incluem: (Sugestão de assinalar qual a técnica será utilizada)
- Bloqueio Nervoso com Agulha Simples: Injeção de anestésico local ou outra medicação diretamente no local-alvo usando uma agulha única. Eficaz para bloquear nervos superficiais ou áreas localizadas. ( )
- Bloqueio Nervoso com Agulha Dupla (Técnica de Cauda de Raposa): Utiliza duas agulhas para injetar anestésico local bilateralmente ao redor de um nervo ou área específica. Pode ser utilizado em blocos nervosos mais extensos ou para melhorar a distribuição da medicação. ( )
- Bloqueio Nervoso Contínuo (Cateter Nervoso): Inserção de um cateter ao longo de um nervo para administrar uma quantidade contínua de anestésico local ou medicamento. Proporciona um bloqueio mais prolongado e controlado, muitas vezes utilizado para analgesia pós-operatória. ( )
- Bloqueio Nervoso Guiado por Ultrassom: Utilização de ultrassom para visualizar as estruturas anatômicas em tempo real e guiar a inserção da agulha. Melhora a precisão e segurança, especialmente em áreas onde a anatomia é mais complexa. ( )
- Bloqueio Nervoso Guiado por Fluoroscopia: Utilização de fluoroscopia (raios-X em tempo real) para orientar a inserção da agulha e monitorar a distribuição da medicação. Útil para procedimentos mais profundos ou quando a visualização direta é desafiadora. ( )
- Bloqueio Nervoso com Neuroestimulação: Utilização de corrente elétrica para estimular o nervo alvo antes da injeção de medicação, ajudando na confirmação da posição adequada da agulha. Aumenta a precisão e eficácia do bloqueio nervoso. ( )

- Bloqueio Nervoso Sindrômico (Gânglio Impar): Bloqueio de um gânglio específico (como o gânglio impar na região sacrococcígea) para aliviar a dor em uma área particular. Pode ser usado em casos de dor pélvica ou perineal. ( )
- Bloqueio Nervoso Simpático (Bloqueio do Plexo Simpático): Interrupção temporária da transmissão de sinais de dor ao longo dos nervos simpáticos. Tratamento de dor neuropática complexa, como na síndrome dolorosa regional complexa (SDRC). ( )
- Bloqueio Nervoso Intratecal (Bomba de Infusão Intratecal): Implante de uma bomba de infusão diretamente no espaço intratecal para administrar medicamentos analgésicos. Tratamento de dor crônica intratável. ( )

As medicações utilizadas em procedimentos de bloqueio nervoso variam de acordo com o objetivo do procedimento e a condição clínica específica do paciente. (Sugestão de assinalar qual a medicação será utilizada)

- Anestésicos Locais: Bloqueiam temporariamente a condução nervosa, proporcionando alívio da dor local. Exemplos: lidocaína, bupivacaína, ropivacaína. ( )
- Corticosteroides: Reduzem a inflamação local, ajudando a controlar a dor de origem inflamatória. Exemplos: dexametasona, triancinolona. ( )
- Bloqueadores Neuromusculares: Pode ser utilizado para bloquear a liberação de neurotransmissores na junção neuromuscular, reduzindo a contração muscular e aliviando a dor associada. Exemplos: botox (toxina botulínica). ( )
- Opioides: Podem ser usados para alívio da dor, especialmente em situações de dor crônica refratária. Exemplos: morfina, fentanil (geralmente administrados por via intratecal ou epidural). ( )
- Agonistas Alfa-2 Adrenérgicos: Tem propriedades analgésicas e pode ser usado como adjuvante para prolongar a duração do bloqueio nervoso. Exemplos: clonidina. ( )
- Anti-inflamatórios não Esteroides (AINEs): Reduzem a inflamação e a dor associada a condições inflamatórias. Exemplos: ibuprofeno, cetoprofeno. ( )
- Soluções Hipertônicas: Podem ser usadas em bloqueios nervosos para reduzir o edema e aliviar a pressão sobre os nervos. Exemplos: manitol. ( )
- Solução Salina (Placebo): Em alguns estudos, uma solução salina pode ser usada como um grupo de controle em ensaios clínicos randomizados. ( )

- Neuroestimuladores Intratecais: Esses dispositivos podem fornecer medicamentos diretamente no espaço intratecal para controle da dor crônica. Exemplos: bombas de infusão intratecal com morfina ou baclofeno. ( )
- Outras Medicações Adjuvantes: Podem ser utilizados para o controle da dor neuropática. Exemplos: gabapentina, pregabalina. ( )

A escolha da medicação dependerá da condição clínica do paciente, da natureza da dor, do tipo de bloqueio nervoso realizado e das preferências da médica de saúde. Além disso, as medicações podem ser administradas de forma isolada ou em combinação para otimizar os resultados do bloqueio nervoso.

- No procedimento o paciente é posicionado de maneira adequada para facilitar o acesso ao nervo alvo. Isso pode envolver a utilização de travesseiros, posicionamento adequado da extremidade ou do corpo, dependendo da área a ser tratada.
- A área ao redor do local de inserção da agulha é limpa para evitar infecções. Em seguida, uma pequena quantidade de anestésico local é administrada para minimizar a dor durante a inserção da agulha.
- Em alguns casos, procedimentos de bloqueio nervoso são orientados por imagem, como ultrassom, fluoroscopia ou tomografia computadorizada. Isso permite que o médico visualize com precisão a anatomia e a posição da agulha em tempo real.
- Uma agulha é inserida na pele e avançada em direção ao nervo alvo. Isso pode ser feito com base em referências anatômicas, estimulação nervosa elétrica ou orientação por imagem.
- Uma vez que a agulha atinge a posição desejada próxima ao nervo, a medicação apropriada é administrada. Essa medicação pode incluir anestésicos locais para bloquear temporariamente a condução nervosa ou corticosteroides para reduzir a inflamação.
- Durante e após o procedimento, o paciente é monitorado para detectar quaisquer reações adversas. A resposta imediata do paciente à intervenção também pode fornecer informações sobre a eficácia do bloqueio nervoso.
- É importante notar que os bloqueios nervosos podem variar em complexidade e técnica com base na área do corpo a ser tratada e na técnica específica utilizada pela médica de saúde.
- Após a realização do procedimento o paciente pode ser encaminhado para a sala de recuperação pós-anestésica onde será monitorado até a ter condições de ser encaminhado a unidade de destino.

- Pacientes de maior risco ou submetidos a procedimentos de maior complexidade podem ser encaminhados a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para maior vigilância.
- O bloqueio de nervos é considerado seguro, visto que os avanços na medicina têm tornado os procedimentos anestésicos cada vez mais seguros ao longo dos anos. No entanto, existem riscos associados, como reações alérgicas a medicamentos, complicações respiratórias e cardiovasculares, e efeitos colaterais indesejados.

3. Dos principais grupos de riscos

Os bloqueios nervosos são procedimentos considerados seguros quando realizados por profissionais de saúde qualificados e em condições clínicas adequadas. No entanto, existem grupos de pacientes que podem apresentar maiores riscos durante ou após esses procedimentos. Alguns dos grupos de maior risco incluem:

- Alergia a Medicamentos: Pacientes com histórico de alergias a anestésicos locais, corticosteroides ou outros medicamentos utilizados nos bloqueios nervosos podem apresentar riscos significativos.
- Coagulopatias ou Distúrbios Hemorrágicos: Indivíduos com distúrbios de coagulação, como hemofilia ou trombocitopenia, podem ter maior risco de sangramento durante ou após o procedimento.
- Infecções Locais ou Sistêmicas: A presença de infecções locais na área de injeção ou infecções sistêmicas pode aumentar o risco de complicações.
- Doenças Neuromusculares Graves: Pacientes com doenças neuromusculares graves, como miastenia gravis, podem ter uma resposta imprevisível aos bloqueios nervosos.
- Doença Cardiovascular Grave: Pacientes com condições cardíacas significativas podem apresentar maior risco durante procedimentos que envolvem estresse físico ou alterações na pressão arterial.
- Doenças Respiratórias Graves: Pacientes com doenças respiratórias graves podem ter maior risco de complicações, especialmente se o bloqueio nervoso afetar áreas que impactam a respiração.
- Gestação: Mulheres grávidas podem ter riscos adicionais, e o procedimento deve ser cuidadosamente considerado, especialmente durante determinados estágios da gravidez.
- Idade Avançada: Pacientes idosos podem apresentar maior fragilidade e maior risco de complicações.

- Doença Neurológica Avançada: Pacientes com doenças neurológicas avançadas podem ter uma resposta variável ao bloqueio nervoso.
- Condições Médicas Gerais Graves: Pacientes com condições médicas gerais graves, como insuficiência renal ou hepática, podem apresentar riscos aumentados.
- Histórico de Reações Adversas Anteriores a Bloqueios Nervosos: Indivíduos que tiveram reações adversas significativas a bloqueios nervosos no passado podem ter um risco aumentado.
- Distúrbios Psiquiátricos Não Controlados: Pacientes com distúrbios psiquiátricos não controlados, como transtornos de ansiedade graves, podem ter maior sensibilidade ao estresse do procedimento.
- Diabetes: Pacientes com diabetes, especialmente se tiverem complicações como neuropatia ou retinopatia diabética, podem ter maior risco de problemas metabólicos durante o procedimento.
- Histórico de Tabagismo: Fumantes têm um risco aumentado de complicações respiratórias durante o procedimento.
- Uso de drogas ou álcool: O uso crônico de substâncias como álcool ou drogas ilícitas pode aumentar o risco de complicações.

É importante informar a médica sobre quaisquer medicamentos, tratamentos ou condições médicas que você esteja enfrentando, para garantir a segurança do procedimento.

4. Dos possíveis riscos do procedimento

O bloqueio de nervos é um procedimento seguro na maioria dos casos, mas como qualquer procedimento médico, pode haver complicações. É importante ressaltar que as complicações graves são raras, e os profissionais são altamente treinados para minimizar os riscos e lidar com qualquer problema que possa surgir durante o procedimento. Algumas complicações potenciais são:

- Reações alérgicas;
- Hematoma;
- Infecção no local do procedimento;
- Lesão nervosa;
- Sangramento excessivo;
- Pneumotórax;

- Reação Vagal;
- Dor prolongada;
- Hipotensão ou hipertensão transitória;
- Lesão vascular;
- Complicações respiratórias;
- Piora da dor;
- Complicações sistêmicas;
- Reações no local da injeção;
- Falha técnica;
- Dor residual;
- Complicações cardíacas;
- Retenção urinária;
- Reações psicológicas;
- Óbito;

5. Dos cuidados pré-procedimento

Fui esclarecido e estou ciente que além de anamnese criteriosa da médica, deverei observar as seguintes orientações:

- Informar a equipe médica sobre quaisquer alergias a medicamentos ou substâncias. Isso é essencial para evitar o uso de medicamentos aos quais você é alérgico.
- Fornece histórico médico completo, incluindo quaisquer condições médicas preexistentes, cirurgias anteriores, hospitalizações e outros detalhes relevantes. Isso permite que a médica adapte o procedimento às suas necessidades específicas.
- Informar sobre todos os medicamentos que faz uso, incluindo prescrições, over-the-counter e suplementos. Em alguns casos, pode ser necessário ajustar a medicação antes da cirurgia.
- Evitar consumir álcool ou tabaco pelo menos 24 horas antes da cirurgia, conforme orientação médica. O álcool e o tabaco podem afetar a resposta à anestesia e a cicatrização.

- Os pacientes devem ficar em jejum por um período de tempo antes do procedimento. Siga as instruções específicas fornecidas pelo anestesiologista quanto ao tempo de jejum. É importante seguir essa orientação rigorosamente para evitar complicações durante o procedimento.

É fundamental seguir as instruções fornecidas pela equipe médica e fazer todas as perguntas necessárias para garantir que esteja bem informado e preparado para o procedimento.

6. Das orientações pós-procedimento

As orientações após o procedimento podem variar dependendo do tipo de procedimento realizado e das políticas específicas do médico ou do local onde a intervenção ocorreu. No entanto, algumas orientações incluem:

- Descanse na posição recomendada pelo médico após o procedimento. Em alguns casos, você pode ser aconselhado a manter a área onde o bloqueio foi realizado imobilizada.
- Siga o monitoramento de perto da área afetada. Se houver dor excessiva, dormência, formigamento, inchaço ou qualquer outra preocupação, informe imediatamente o seu médico.
- Dependendo do tipo de bloqueio de nervos e da área afetada, você pode ter restrições de atividades temporárias. Evite atividades que possam colocar estresse na área bloqueada.
- Se o médico prescrever medicamentos para dor, tome-os conforme as instruções. Não altere a dosagem ou interrompa o uso sem consultar o seu médico.
- Se recomendado pelo médico, a aplicação de gelo na área afetada pode ajudar a reduzir o inchaço e aliviar a dor. Use um pano fino entre o gelo e a pele para evitar queimaduras por frio.
- Siga as instruções do seu médico para começar a comer e beber gradualmente. Evite alimentos pesados ou que possam causar desconforto digestivo nas primeiras horas após o procedimento.
- Beba líquidos conforme recomendado pelo seu médico. A hidratação adequada é importante para a recuperação.
- Mantenha todas as consultas de acompanhamento agendadas com a médica para que ele possa avaliar a sua recuperação e fazer ajustes conforme necessário.
- Esteja atento a qualquer sinal de complicação, e informe imediatamente o seu médico se notar qualquer um desses sintomas.
- Se a área bloqueada estiver em uma extremidade, siga as instruções do seu médico sobre quando e como iniciar a mobilização e a fisioterapia.
- Evite dirigir ou operar máquinas durante o período especificado pelo seu médico.

- É importante permitir que a medicação usada durante o bloqueio de nervos desapareça completamente antes de retomar as atividades normais.

É fundamental seguir as orientações do seu médico ou da equipe de saúde responsável pelo seu cuidado para garantir uma recuperação segura e eficaz.

7. Dos resultados

Os bloqueios nervosos podem proporcionar alívio significativo da dor em muitos casos, mas também é importante compreender que existem limitações e variabilidades nos resultados desses procedimentos.

O alívio da dor proporcionado pelo bloqueio nervoso pode ser temporário. A duração efetiva pode variar de acordo com a medicação utilizada, a condição clínica do paciente e outros fatores.

A resposta ao bloqueio nervoso pode variar de pessoa para pessoa. Alguns pacientes podem experimentar alívio imediato e duradouro, enquanto outros podem ter apenas um alívio parcial ou nenhum alívio.

A dor muitas vezes é multifatorial, com várias causas contribuindo para a experiência dolorosa. O bloqueio de um nervo específico pode não abordar todas as fontes de dor.

Em alguns casos, pode ser necessário realizar retratamentos para manter ou estender o alívio da dor ao longo do tempo.

Se a dor tiver uma causa subjacente que não pode ser abordada através de bloqueios nervosos (por exemplo, uma lesão estrutural importante), os resultados podem ser limitados.

Existem riscos associados aos bloqueios nervosos, e complicações podem ocorrer, embora sejam relativamente raras. Isso pode afetar a eficácia do procedimento.

Algumas condições médicas específicas, como certas neuropatias periféricas ou danos nervosos irreversíveis, os bloqueios nervosos podem ter limitações significativas em termos de eficácia.

Parte do efeito percebido do bloqueio nervoso pode ser atribuída a fatores psicológicos, como o efeito placebo.

Em muitos casos, o tratamento eficaz da dor requer uma abordagem multidisciplinar, que pode incluir além de bloqueios nervosos, terapia física, medicação oral, modificação do estilo de vida, entre outros.

8. Das declarações e consentimentos

- **FUI INFORMADO(A),** de modo claro e completo, sobre o procedimento, seus benefícios esperados, as alternativas disponíveis (inclusive a de não realizar o tratamento), as consequências de não realizá-lo, os riscos, as possíveis complicações e o período de recuperação. Pude fazer perguntas e recebi respostas que julguei suficientes.
- **RECEBI** ESTE TERMO com antecedência, em _____/_____/_____, e tive tempo para lê-lo com calma, conversar com pessoas de minha confiança e, se quisesse, buscar uma segunda opinião antes de assiná-lo.
- **EXPUS** À MÉDICA o que espero do procedimento. Ela me explicou o que é possível alcançar no meu caso, quais são os limites e o que não é possível alcançar.

Minha queixa e o que espero do procedimento:

Riscos ou cuidados específicos do meu caso, discutidos na consulta:

- **AFIRMO** ter feito um relato cuidadoso e verdadeiro da minha história pessoal e familiar de saúde física e mental, incluindo alergias, doenças, cirurgias e procedimentos anteriores, sangramentos e reações a medicamentos ou anestésicos. Entendo que omitir informações pode resultar em complicações importantes.
- **COMPROMETO-ME** a informar todo e qualquer medicamento, suplemento, fitoterápico ou outra substância, lícita ou ilícita, utilizados nos 7 (sete) dias anteriores ao procedimento, além do consumo de álcool.
- **ESTOU** CIENTE de que deixar de prestar informações verdadeiras, não seguir as orientações e prescrições ou abandonar o acompanhamento pode prejudicar o resultado e causar complicações, e que essas condutas poderão ser consideradas como minha contribuição para o resultado (art. 945 do Código Civil e art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor).
- **DECLARO** que nada omiti em relação à minha saúde e autorizo que esta declaração integre meu prontuário, podendo ser utilizada pela médica no exercício regular de seus direitos, inclusive em

processo judicial ou administrativo (art. 7º, VI, e art. 11, II, "d", da Lei nº 13.709/2018). Autorizo também que a médica solicite, quando necessário para a minha assistência, cópias de exames e informações de outros serviços de saúde onde eu tenha sido atendido(a).

- **RECONHEÇO** que, durante o procedimento, podem surgir situações novas que não puderam ser identificadas antes. Nesses casos, AUTORIZO a médica e sua equipe a adotar as medidas necessárias para preservar minha saúde e segurança. Procedimentos adicionais com finalidade apenas estética não serão realizados sem meu consentimento prévio.
- **FUI ORIENTADO(A)** sobre os cuidados antes e depois do procedimento, que devo cumprir rigorosamente, e sobre as possíveis intercorrências. Estou ciente de que devo comparecer aos retornos agendados e de que minha ausência será registrada no prontuário e poderá caracterizar abandono do acompanhamento.
- **RECEBI** o contato da equipe para dúvidas e intercorrências: WhatsApp (21) 97440-2673. Em caso de urgência ou emergência, devo procurar o pronto-socorro mais próximo e avisar a médica assim que possível.
- **FUI INFORMADO(A),** por orçamento escrito, sobre os valores do procedimento. Retoques, procedimentos complementares e o tratamento de eventuais intercorrências seguirão as condições descritas nesse orçamento; o que não estiver incluído nele me será informado e orçado previamente.

FOTOGRAFIAS E VÍDEOS

Autorizo que sejam feitas fotografias e vídeos antes, durante e depois do procedimento, para compor meu prontuário e acompanhar minha evolução. Esses registros fazem parte do meu atendimento e são mantidos em sigilo.

Além do prontuário (marque uma ou mais opções):

( ) Autorizo o uso em aulas, congressos e publicações científicas, sem identificação.

( ) Autorizo o uso em materiais de divulgação da médica (site e redes sociais), sem identificação e com finalidade educativa, conforme a Resolução CFM nº 2.336/2023.

( ) Não autorizo nenhum uso além do prontuário.

Minha escolha não interfere no meu atendimento. Posso revogá-la a qualquer momento, por escrito, sem efeito sobre o que já tiver sido publicado antes da revogação.

PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (LGPD)

A controladora dos meus dados pessoais é a Dra. Dunia Verona (contato: draduniaverona@gmail.com). Meus dados, inclusive os de saúde, são tratados para a minha assistência e para o cumprimento de obrigações legais e regulatórias (art. 7º, II, e art. 11, II, "a" e "f", da Lei nº 13.709/2018). Eles só serão compartilhados com quem participa do meu cuidado (como hospital, laboratório, equipe de anestesia e fornecedores, quando necessário) ou por determinação legal. O prontuário é guardado por, no mínimo, 20 (vinte) anos (Lei nº 13.787/2018). Posso solicitar acesso, correção e informações sobre o uso dos meus dados pelo e-mail acima (art. 18 da LGPD).

REVOGAÇÃO E ASSINATURA

- **FUI INFORMADO(A)** de que posso revogar meu consentimento a qualquer momento antes do início do procedimento, comunicando minha decisão à médica e assinando o Termo de Revogação, que me será entregue quando eu manifestar essa vontade. As condições financeiras da desistência seguem o orçamento.
- **CONFIRMO** que este termo formaliza um processo de informação e esclarecimento iniciado na primeira consulta.
- **LI ESTE** TERMO POR INTEIRO, rubriquei todas as suas páginas e recebi uma via assinada.

O presente Termo é firmado em 2 (duas) vias de igual teor, uma destinada ao(à) paciente e outra à médica.

( ) CONSINTO ( ) RECUSO a realização do procedimento de bloqueio nervoso.

Rio de Janeiro – RJ, ____ de _____ de 20____.

_____

Assinatura do(a) paciente

Nome completo:

_____

Responsável legal, se paciente menor de idade ou incapaz

Nome, CPF e parentesco:

_____

Testemunha (opcional)

Nome e CPF:

Declaração da médica

Declaro que informei, expliquei e esclareci todas as dúvidas do(a) paciente sobre o procedimento de bloqueio nervoso, seus benefícios, riscos, alternativas e efeitos adversos, e que o(a) paciente, ou seu responsável legal, demonstrou ter compreendido o que foi tratado neste termo. Comprometo-me a prestar assistência de forma diligente, prudente e eficiente.

Rio de Janeiro – RJ, ____ de _____ de 20____.

_____

Dra. Dunia Verona

Cirurgiã plástica · CRM-RJ 52 0126416-8 · RQE 60527